



CONSELHO ADMINISTRATIVO FUNSERV

Mandato 2024/2028

Exercício 2024

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA - FUNSERV

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se no prédio sede da FUNSERV, sito à Rua Major João Lício, 265 – Centro – Sorocaba/SP, reunião extraordinária do Conselho Administrativo da FUNSERV. Em atenção à convocação da Presidente do Conselho publicada à fl. 19 do diário oficial, no dia 11 de outubro de 2024, em primeira chamada às 10h00 e em segunda chamada às 10h15, deu-se início à reunião, onde deliberaram sobre o que segue: SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 17 da Lei Municipal nº 4169/1993): 1) Verificação de quórum: iniciando a reunião, a Sra. Silvana Chinelatto, Presidente do Conselho Administrativo da Funserv, passou a conduzir a pauta, após abertura oficial, verificação de quórum e saudação. SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA: (arts. 18 e seguintes da Lei Municipal nº 4169/1993). **ITEM 1: TRANSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO.** Sra. Silvana deu início à reunião agradecendo ao Conselheiro Paulo Marquês que esteve à frente, interinamente, como Presidente do Conselho Administrativo nesses últimos seis meses, em decorrência de seu afastamento do Conselho por motivos de sua candidatura eleitoral. Sr. Paulo Marquês também fez seus agradecimentos pela oportunidade de acompanhar e crescer junto com o Conselho, lembrando os temas e avanços observados nesse período. **ITEM 2: REFORMA FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE FUNSERV.** Sra. Silvana passou a palavra ao Sr. Fábio, presidente da Funserv, para dar início ao tema principal da reunião. Sr. Fábio deu início à essa importante pauta frisando sobre uma realidade na Funserv Saúde que vem desde o ano de 2015 de forma deficitária, e que se agrava mais a cada ano que passa, fazendo-se urgente a necessidade de uma reforma financeira. Reforçou que atualmente encontra-se num sistema impagável, onde o que se arrecada é menor do que se paga, passou a palavra ao Diretor Adm. e Financeiro, Sr. Edgar, para dar início à apresentação dos estudos. Sr. Edgar iniciou informando que a apresentação, bem como todo o estudo, foram construídos pela Diretoria Financeira, que tem como obrigação por legitimidade equilibrar a despesa e a receita da Funserv Saúde, juntamente com a Diretoria Executiva e Gestão da saúde. Apresentou o cenário atual da saúde, conforme se vem falando em reuniões anteriores, já consolidado que se arrecada 14 milhões contra 17 milhões de despesa, um déficit mensal aproximado de 3 milhões de reais. Buscou-se desde o mês de maio deste ano o aporte do 13º salário patronal. O Secretário da Fazenda da Prefeitura, Sr. Marcelo Regalado, encaminhou no mês de maio 1,5 milhões, encaminhou no mês de junho mais 1 milhão de reais, e depois não teve condições de aportar mais nada de recurso. Neste cenário, a Funserv deve hoje 2 milhões e cem mil reais ao prestador Hospital Evangélico, a serem pagos no dia 20 de dezembro, conforme combinado entre as partes. No pagamento de julho faltou mais dinheiro, ou seja, a Funserv começou a entrar num rotativo de déficit. Mês de agosto houve a mesma situação ocasionando em novos parcelamentos e foram envolvidos além do Hospital Evangélico, os prestadores Devita e IOS (maiores prestadores oncológicos). No mês de setembro envolveu além desses, também o prestador Centro Médico. Neste mês de outubro foram envolvidos um total de 05 prestadores nesses parcelamentos, incluindo desta vez o Hospital Notre Care, conforme cronograma de parcelamentos e pagamentos apresentados nos slides. Atualmente a Funserv possui uma dívida líquida de 9,4 milhões (nove milhões e quatrocentos mil reais). Edgar apresentou os estudos que apresentam a desconexão entre as receitas e as despesas, tendo o índice acumulado de reajuste do custo médico hospitalar nos últimos anos que somam 250% (de 2015 à 2023 nesse segmento), comparando com o reajuste salarial do funcionalismo público municipal no mesmo período, único mecanismo de ampliação de receitas na Funserv saúde, que foi

de 66%. Apresentou outros índices de aumento na utilização do sistema por parte dos servidores, conforme demonstrado nos slides. Demonstrou ainda como funcionam as contribuições hoje, divididas por faixa etária, conforme previsto na atual legislação, e respectivos números de beneficiários em cada faixa, titulares e dependentes, demonstrando, inclusive, que o sistema possui atualmente 1.540 filhos isentos, sem qualquer contribuição para a Assistência a Saúde, dada a faixa salarial do servidor titular, e o filho que mais contribui, contribui com R\$ 76,00, conforme demonstrado na apresentação dos slides. Por fim, Sr. Edgar demonstrou aos Conselheiros 02 propostas para solucionar o déficit: No primeiro cenário, a contribuição do titular continuaria proporcional ao piso salarial, aumentando em 05 faixas de descontos, alterando-se a cada 02 pisos e conforme vai reajustando o piso reajusta o desconto. E o desconto do filho variaria de 8% até 14% do piso da categoria. Com essa alteração, o sistema sairia de R\$ 380.000,00 mil arrecadados hoje com os filhos, para R\$ 1.340.000,00, um aumento de 1 milhão. Explicou que essa sistemática é extremamente complexa para o RH, complexo para fazer gestão, pois deverá cruzar diversos dados salariais. Um cenário operacionalmente mais simples teria o valor de desconto do filho fixo, no valor de R\$ 240,00, 11% do piso salarial, independente da faixa salarial do servidor, aumentando em 1.225.000,00 a receita só na categoria filho. Com os cônjuges seguiria o mesmo raciocínio. Na primeira ideia, em 05 faixas salariais, com um percentual um pouco maior e mais justo, seria de 300,00 até 478,00, de 14 à 22% do piso salarial, que traria uma ampliação de receita de 1.184.000,00. No segundo modelo linear, proposta de valor fixo de R\$ 390,00, o que representa 18% do piso pra todos, traria uma receita de R\$ 1.414.000,00. Dependentes por ordem judicial seriam todos reajustados para R\$ 540,00. Sr. Edgar explicou que neste cenário de ajustes para dependentes filhos e cônjuges, teríamos um aumento de receita em 2,5 milhões de reais. Lembrou que nos dois cenários não haveria mais filhos isentos, nem mesmo os filhos inválidos seriam mais isentos. Edgar ainda lembrou a grande polêmica que existe no funcionalismo com relação ao piso salarial, pois quem ingressou até julho de 2018, contribui com o mínimo de 10% sobre o piso salarial, e quem ingressou após essa data, contribui com o mínimo de 20% sobre o piso da categoria. Proposta da diretoria: todos pagarem o mínimo de 25 % sobre o piso salarial. Apresentou também um comparativo com plano de saúde regulados pela ANS, como Plano Regional, Unimed Fesp, Unimed Unipart, CAPEP de Santos que possui uma realidade de Assistência a Saúde parecida com a da Funserv. Pra concluir, apresentou 02 propostas elaboradas pela Diretoria Financeira para se analisar: proposta 01 dentro do modelo atual, sem coparticipação, servidor alterando de 6 para 7% do servidor titular, patronal de 5 para 7% e piso salarial de desconto para 25%. Na proposta 02 com coparticipação, alterando de 6 para 7% do servidor titular, patronal de 5 para 7% e mantando o piso salarial de desconto em 20%. Explicou ainda sobre como funcionaria a coparticipação caso seja aprovada: 25% de participação em consultas e exames, 30% em terapias e fisioterapias, com base na tabela Funserv, estabelecendo um limite anual. Quimioterapia, radioterapia, internação, hemodiálise, mamografia e outros não haveria a coparticipação. Pra finalizar, Sr. Edgar trouxe proposta do Comitê da Saúde conforme segue: Servidor titular para 7%, Patronal para 7%, mínimo de 25% sobre piso salarial, 59+ para 30% de desconto, dependentes nas tabelas lineares, dependente filho ampliar até 24 anos, cursando ou não ensino superior. O Comitê da saúde ainda propõe alterar a Lei que hoje prevê que a regulação da Assistência à Saúde somente pode ser feita através de Decreto do Prefeito, mudar para dar autonomia à Funserv gerenciar isso, competindo aos órgãos colegiados em conjunto gerenciar, sendo eles: Comitê da Saúde, Conselho Administrativo, Diretoria Executiva, Gestor da Saúde, Comitê de Investimentos. Comitê da Saúde sugeriu ainda encaminhar à Prefeitura para prever na legislação a permissão para que a Prefeitura cubra eventual déficit na Assistência a Saúde, no valor de até 50% da patronal daquele mês. Deu por encerrada a apresentação colocando-se a disposição para dúvidas e esclarecimentos. Presidente do Conselho, Sra. Silvana abriu para perguntas. Sr. Alexandro disse que entendeu a necessidade de mudança no sistema da Saúde, mas disse que não tem segurança para votar uma situação como essa nessa reunião. Sugeriu aos colegas não votar proposta alguma e agendar outra reunião para discutir melhor as propostas

apresentadas. Disse que ficou um pouco confuso diante das propostas apresentadas. Sr. Edgar esclareceu que precisa da aprovação de todas as medidas contidas dentro de cada proposta, que o “combo” é que trará a receita que precisa para equilibrar o sistema. Conselheira Áurea informou, como membro do Comitê da Saúde, que o tema foi exaustivamente debatido no Comitê, esclareceu que ela própria é contra a coparticipação e que a proposta votada no Comitê foi a proposta 01, sem coparticipação. Comentou também sobre a mudança na Lei para dar mais autonomia à Funserv, explicou que não é uma mudança pra agora, mas ter essa previsão na Lei para que, quando for necessário, no futuro, a própria Funserv possa realizar as adequações necessárias, e somente, se muito necessário num futuro, voltaria a pensar na coparticipação. Sr. Alexandro comentou sobre as possibilidades apresentadas inclusive, sobre a exclusão dos dependentes no sistema, pois somente com servidores titulares o sistema seria superavitário, conforme apresentado pelo Sr. Edgar. Sra. Tatiana, membro do Conselho Fiscal mencionou que a mudança será difícil de qualquer forma, tudo terá impacto sob qualquer cenário, mas enfatizou que é necessária. Considerou que não é de bom tom excluir os dependentes do sistema e concluiu que não deve sequer constar na proposta para votação. Sr. Alexandro concordou em não excluir dependentes, mas ressaltou se atentar às propostas que falam da coparticipação ou não. Sr. Paulo Marquês elogiou a forma como as propostas foram trazidas, de forma fácil de compreender. Mencionou que é difícil decidir nesse momento, pois decidir a Assistência a Saúde nesse momento é decidir vidas, e que não é possível decidir vidas sem ouvir essas vidas, sem saber o que essas pessoas pensam. Comentou também que é muito difícil discutir qualquer alteração de Lei na Câmara nesse momento, dada a proximidade com o final do ano. Sr. Paulo enfatizou também que é preciso falar em sustentabilidade pelos próximos anos na Saúde Funserv. Considerou que é preciso ser menos assistencialistas e pensar mais como negócio, pois a Saúde é um negócio do servidor que põe seu dinheiro mensalmente, disse que precisamos ensinar o servidor a pensar desta forma e que é preciso pensar lá na frente. Por fim, concordou com o Sr. Alexandro sobre a impossibilidade de se votar esse projeto nesse momento. Sugeriu aos conselheiros ouvir o servidor antes de decidir. Sr. Paulo de Tarso mencionou o peso da responsabilidade nesta decisão que não pode ser tomada bruscamente. Perguntou à conselheira Áurea o porquê do Comitê da Saúde ser conta a coparticipação agora. Dr. Áurea explicou que houve um consenso no Comitê de que a coparticipação é ruim para quem usa mais o sistema, como os idosos, por exemplo. Disse que os mais desafortunados ou quem possui doença crônica seriam mais prejudicados com a coparticipação. Sr. Túlio disse que defende uma categoria que é doente e que faz tratamentos constantes, e que não podem ficar sem a Assistência a Saúde. Disse ainda que é contra a coparticipação, mas que se for realmente necessária, que haja isenção de três ou quatro consultas/mês. Disse também ser a favor da Funserv ter seu próprio laboratório, trabalhando com grandes empresas parceiras. Sr. Pedro Rosa sugeriu igualar os dependentes filhos, os “normais” com os de via judicial. Sr. Marco Massari pediu prazo de pelo menos dois ou três dias para pensar melhor nas propostas apresentadas. Sra. Tatiana sugeriu montar mais propostas incluindo a sugestão do Sr. Pedro Rosa, e apresentá-las novamente para melhor análise. Presidente Silvana sugeriu à diretoria a realização de plenárias para ouvir os servidores a respeito do tema. Sugeriu também à diretoria chamar as Associações e entidades representantes e classe para abrir diálogo e discussão sobre a reforma. Sr. Edgar, acatando a sugestão apresentada, estipulou um cronograma para as plenárias iniciando com as Associações e Entidades, na sequência convidará servidores e beneficiários mais influentes e formadores de opinião dentro da rede, e depois montará cronograma para a realização de plenárias junto aos servidores. Sr. Paulo Marquês sugeriu também extinguir os Grupos de Trabalhos formados no início da gestão por não ter funcionado na prática como previsto. Presidente Silvana retomou a palavra para dar início ao encerramento da reunião com o que segue: encaminhamento dos GTs (Grupos de trabalhos) ficam extintos a partir de agora. O encaminhamento das propostas da reforma financeira da Assistência à Saúde ficou decidido que a diretoria deverá se reunir com o Executivo para discussão do assunto. Diretoria da Funserv deverá ainda reunir-se com todas as entidades e associações com representação de classe para

explicar as dificuldades da Assistência a Saúde, mostrar a necessidade da reforma e ouvir as opiniões. Presidente Silvana solicitou aos conselheiros pesquisarem quais são essas entidades e encaminhar à diretoria para contato, até o final da tarde do dia seguinte desta reunião. Solicitou à diretoria também verificar junto ao RH quais mais possuem repasse em folha de pagamento. Presidente Silvana frisou que, considerando não ter havido consenso neste grupo de conselheiros sobre como deve ser feita essa reforma, que os conselheiros devem unir-se à diretoria para ouvir os colegas servidores, bem como os representantes de classe, defendendo que a reforma se faz urgente e necessária para a manutenção do sistema. Após ouvir os servidores e representantes de classe, ficará mais fácil do conselho votar e encaminhar ao executivo para a alteração da Lei. Todos os presentes aprovaram esse direcionamento da presidente à diretoria executiva da Funserv. Sr. Fábio Salun sugeriu já deixar agendada essa primeira reunião com as Associações e entidades de classe para a próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, para dar início à esse diálogo com os servidores sobre a Assistência a Saúde Funserv, ao que todos concordaram. SEÇÃO III – ENCERRAMENTO: Após verificar que não existia mais assunto a ser tratado, a presidente deu encaminhamento ao encerramento da reunião, agradecendo a todos os Membros presentes na reunião, os quais seguem abaixo relacionados. Não havendo nada mais a tratar, encerraram-se os trabalhos às 13h15min e para constar eu, Ana Lúcia Bittencourt Rosa, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai por mim assinada e, posteriormente, publicada junto ao site da Funserv, ficando a próxima reunião ordinária designada para 30/10/2024, quarta-feira, conforme previsto na Resolução FUNSERV nº 07/2024.-----

Membros presentes:

MARIA DO SOCORRO SOUZA LIMA
EDGAR APARCIDO FERREIRA DA SILVA
ADJALMA LUIZ ORSI GOMES FERREIRA
ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA
AMANDA CRISTINA NUNES SCHIAVI
ANA LÚCIA BITTENCOURT ROSA
ANDRE AUGUSTO
AUREA ISCARO ANDRADE
FABIO SALUN SILVA
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
LEILA REGINA OLIVEIRA CHINELATTO
MARCO ANTONIO LEITE MASSARI
MARILDA APARECIDA CORREA
PAULO ANTONIO DE SOUSA MARQUEZ
PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA
PEDRO DE OLIVEIRA ROSA
TULIO MARCUS PERFETTO
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO
WANDERLENE APARECIDA MARIANO LOPES
CILSA REGINA GUEDES SILVA
FRANCINE CASARE
MARIA VANUZA BARBOSA DOS SANTOS
TATIANA MATUCCI CASAGRANDE
ROBERTA GLISLAINE AP. PEREIRA
DORIVAL DEL'OMO
JOSÉ MARCOS TRINDADE

Ana Lúcia Bittencourt Rosa
Secretária do Conselho Administrativo